OBI

ASL Salento Adriatico
Ospedale dei Bambini Madonna dell'Idria
U.O.C. Pediatria - Ambulatorio di Allergologia Pediatrica

Viale Otranto 96
73100 Lecce
Tel. 0832 661240 (lun-ven 9-13)

VISITA ALLERGOLOGICA PEDIATRICA

Prima visita (cod. 89.7) - Prick test per inalanti (cod. 91.90.6) - Spirometria semplice (cod. 89.37.1)

DATI DEL PAZIENTE

Cognome:	**Greco**	Nome:	**Tommaso**
Data di nascita:	**21/04/2016**	C.F.:	**GRCTMS16D21E506J**
Residenza:	**Via Taranto 51, Lecce**	Accompagnato da:	**Valentina Quarta (madre)**
Recapito genitore:	**+39 349 220 7815**	Pediatra (PLS):	**Dott.ssa Ilaria Miglietta**

Data visita: 12/02/2025 NRE: 160A50340091827 Priorità: D (entro 30 gg)

ANAMNESI

Tommaso, di 8 anni, frequenta la classe terza presso l'Istituto Comprensivo Rudiae. Giunge accompagnato dalla madre, sig.ra Quarta, che riferisce da circa due anni rinorrea acquosa, starnutazioni a salve e prurito oculare nei mesi primaverili, con frequenti assenze scolastiche, e due episodi di broncospasmo con tosse notturna nella primavera 2024, trattati dal pediatra con salbutamolo spray con beneficio.
Anamnesi familiare: padre con rinite allergica; il fratello Leonardo, di 5 aa., è seguito per dermatite atopica.
Nato a termine da parto eutocico, allattamento materno. Vaccinazioni secondo calendario. Non reazioni avverse a farmaci o alimenti. Vive in appartamento al secondo piano, non animali domestici.

ESAME OBIETTIVO

Buone condizioni generali. Peso 28 kg (50° percentile), altezza 131 cm (50°-75° percentile). Pieghe di Dennie-Morgan presenti; occhiaie allergiche. Mucosa nasale pallida con turbinati ipertrofici, secrezione sierosa. Murmure vescicolare normotrasmesso, non rumori aggiunti. SpO2 98% in aria ambiente. Cute integra, non lesioni eczematose.

PRICK TEST PER INALANTI

Lettura a 15 minuti. Il bambino non assumeva antistaminici da almeno 7 giorni.

Allergene	Diametro pomfo	Esito
Controllo negativo (soluzione fisiologica)	0 mm	
Controllo positivo (istamina 10 mg/mL)	6 mm	
Graminacee (Phleum pratense)	11 mm	+++
Olivo (Olea europaea)	7 mm	++
Parietaria judaica	4 mm	+
Dermatophagoides pteronyssinus	assente	
Epitelio di gatto / cane	assente	
Alternaria alternata	assente	

Spirometria con test di broncodilatazione

Eseguita dalla Dott.ssa Serena Rizzo (Pneumologia pediatrica): FEV1 89% del teorico, FEV1/FVC 0,82. Dopo salbutamolo 400 mcg con distanziatore incremento del FEV1 del 13% (test positivo). Collaborazione buona.

CONCLUSIONI

Rinocongiuntivite allergica stagionale da pollini di graminacee e olivo (lieve sensibilizzazione a parietaria). Asma bronchiale lieve intermittente con reversibilità significativa al broncodilatatore.

Terapia e indicazioni

Farmaco	Dose	Quando
Mometasone spray nasale 50 mcg	1 erogazione per narice	ogni sera, da marzo a giugno
Cetirizina gocce 10 mg/mL	10 gocce	la sera, nei periodi di sintomi
Salbutamolo 100 mcg spray	2 puff con distanziatore	al bisogno, ripetibili dopo 20 min

Valutare immunoterapia specifica sublinguale per graminacee al termine della stagione pollinica. Si consegna alla madre il piano d'azione scritto per l'asma. L'infermiera Antonella Calò ha addestrato la sig.ra Quarta e il bambino all'uso corretto del distanziatore.
Si rilascia certificato per la somministrazione del salbutamolo in orario scolastico, da consegnare alla segreteria dell'Istituto Comprensivo Rudiae.
Controllo: 15/10/2025 con spirometria, già prenotato.

Documentazione consegnata al genitore

☒ Referto della visita ☒ Piano d'azione per l'asma ☒ Certificato per la scuola

Il Pediatra Allergologo

Dott. Fabio Marzo

Dott. Fabio Marzo
Specialista in Pediatria e Allergologia
Iscr. Albo n. LE-04416

Lecce, 12 febbraio 2025

Referto online: https://referti.aslsalento.example.it/r/PED-ALL-25-00412